الأداة 4 / 5

المخطِّط السريري ذو المراحل الأربع

التشخيص ← الأهداف ← الميكانيكا ← المتابعة. ورقة تخطيط قابلة للطباعة والتعبئة باليد لكل حالة.

قبل أن تبدأ

كيف تستخدم المخطط؟

اطبع الورقة لكل حالة جديدة؛ واحفظها في ملف المريض.

الخطة تولد من قائمة المشكلات. التشخيص أولًا، ثم الهدف، والميكانيكا أخيرًا. إن اختل الترتيب طال العلاج.

1. **المرحلة 1 · التشخيص** – املأ الوجه والإطباق وتحليل المسافة والتحليل السيفالومتري والصورة البانورامية. استخدم الأداة 1 للبانورامية والأداة 3 للتصنيف. وفي النهاية اكتب قائمة المشكلات حسب الأولوية.
2. **المرحلة 2 · الأهداف** – اكتب هدفًا لكل مشكلة: الوجه، إنهاء الأرحاء والأنياب، التراكب الأفقي والعمودي، الخط الناصف. قرّر الخلع بالأداة 2؛ وحدّد هنا حاجة الإرساء.
3. **المرحلة 3 · تسلسل الميكانيكا** – اكتب ترتيب بلوغ الأهداف. لكل خطوة سلكها القوسي أو جهازها المساعد. علّم ما أُنجز.
4. **المرحلة 4 · المتابعة والإنهاء** – بانورامية وسيطة، إعادة تموضع الحاصرات، مفاتيح الإطباق الستة وخطة التثبيت. قبل نزع الحاصرات يجب تعليم كل سطر.

قاعدة

السطر الفارغ قرار لم يُتخذ بعد. قبل لصق الحاصرات يجب أن تكتمل المرحلتان 1 و2؛ ثم أجرِ التحقق الأخير بالأداة 5.

خطأ شائع

كتابة تسلسل الميكانيكا بحكم العادة. أولًا التصحيح العرضي والتقويمي العظمي، ثم التسوية؛ ولا تصحيح سهمي ما دامت العضة العميقة غير مفتوحة.

المربعات

علّم الخيار المناسب؛ وإن لم يكن في القائمة فاكتبه في آخر السطر.

التعديل

إن تغيرت الخطة فاشطب السطر القديم واكتب بجانبه التاريخ والقرار الجديد.

المخطط · صفحة 1

المرحلة 1 · التشخيص

لا تنتقل إلى المرحلة 2 قبل اكتمال كل السجلات.

المريض / العمر / التاريخ

الشكوى الرئيسية

العادات ☐ مص الإصبع ☐ تنفس فموي ☐ دفع اللسان ☐ صرير الأسنان

الوجه

الجانبية ☐ مستقيمة ☐ محدبة ☐ مقعرة

الشفتان ☐ مرتاحتان ☐ متكلّفتان ☐ بارزتان ☐ متراجعتان

الخط الناصف الوجهي / الذقن

الابتسامة ☐ لثة ظاهرة كثيرًا ☐ ممر خدّي عريض ☐ طبيعية

الإطباق

الأرحاء / الأنياب (يمين · يسار)

التراكب الأفقي / العمودي (mm)

الخط الناصف علوي / سفلي (mm)

العضة المعكوسة / المقصية

منحنى سبي ☐ مسطح ☐ متوسط ☐ عميق

الانزلاق الوظيفي (CR–CO) ☐ لا يوجد ☐ يوجد: ____ mm

المفصل الصدغي الفكي ☐ لا موجودات ☐ صوت ☐ ألم ☐ فتح محدود

المسافة والتحليل السيفالومتري والسجلات

حاجة المسافة علوي / سفلي (mm)

تحليل بولتون ☐ متناسب ☐ زيادة علوية ☐ زيادة سفلية

SNA / SNB / ANB · Wits

FMA / SN-GoMe · IMPA / U1-SN

البانورامية (الأداة 1) ☐ سلبية ☐ توجد موجودة ←

حول السنية / النمط ☐ سميك ☐ رقيق ☐ يوجد انحسار

مرحلة النمو ☐ قبل الذروة ☐ في الذروة ☐ منتهية

التشخيص التفريقي (الأداة 3) ☐ سني ☐ عظمي ☐ كاذب

قائمة المشكلات (حسب الأولوية)

المخطط · صفحة 2

المرحلة 2 · الأهداف

لكل مشكلة هدف واحد. وليكن الهدف قابلًا للقياس.

الهدف الوجهي	☐ حفظ الجانبية ☐ تقليل دعم الشفة ☐ زيادة دعم الشفة
إنهاء الأرحاء يمين / يسار	☐ الصنف الأول ☐ صنف ثانٍ كامل ☐ صنف ثالث كامل
إنهاء الأنياب	☐ الصنف الأول
هدف التراكب الأفقي / العمودي (mm)	
الخط الناصف	☐ تصحيح ☐ قبول
وضع القواطع	☐ حفظ ☐ إرجاع ☐ ميلان أمامي مضبوط
العرضي	☐ لا يلزم ☐ RME ☐ توسيع سنخي سني
العمودي	☐ حفظ ☐ فتح العضة العميقة ☐ إغلاق العضة المفتوحة
قرار الخلع (الأداة 2)	☐ دون خلع ☐ خلع: _____
حاجة الإرساء	☐ دنيا ☐ متوسطة ☐ قصوى
وسيلة الإرساء	☐ TPA ☐ قوس Nance ☐ زرعة مصغرة ☐ مطاط

الحدود / التنازلات المقبولة

شُرح للمريض	☐ الخيارات ☐ المدة ☐ التثبيت

المرحلة 3 · تسلسل الميكانيكا

اكتب الترتيب وعلّم ما أُنجز. لا تنتقل إلى الخطوة التالية قبل إنجاز السابقة.

✓	الخطوة	السلك / الجهاز / المساعد	تاريخ البدء
☐	التقويم العظمي / التوسيع		
☐	التسوية والترصيف		
☐	العضة العميقة / منحنى سبي		
☐	إغلاق الفراغات		
☐	التصحيح السهمي		
☐	الخط الناصف		
☐	التنقيح (torque، الدوران)		

المرحلة 4 · المتابعة والإنهاء

تواتر المراجعات

بانورامية وسيطة (توازي الجذور) ☐ مخطط لها ☐ أُنجزت

إعادة تموضع الحاصرات ☐ لا يلزم ☐ الأسنان: _____

مفاتيح الإطباق الستة ☐ الأرحاء ☐ زاوية التاج ☐ ميلان التاج ☐ الدوران ☐ التماس ☐ مستوى الإطباق

التراكب الأفقي / العمودي / الخط الناصف ☐ عند القيمة المستهدفة

التثبيت العلوي ☐ لساني ثابت ☐ Hawley ☐ Essix

التثبيت السفلي ☐ لساني ثابت ☐ Hawley ☐ Essix

خطر الانتكاس / ملاحظة

مثال

مثال مكتمل

حالة افتراضية. يكفي أن تكتب حالتك بالقدر نفسه من التفصيل.

1 · التشخيص

المريض	فتاة 13 سنة. الشكوى: «أسناني العلوية بارزة.»
الوجه	جانبية محدبة، ذقن متراجعة؛ إغلاق شفوي متكلّف
الإطباق	أرحاء وأنياب صنف ثانٍ في الجانبين؛ تراكب أفقي 8 mm، عمودي 5 mm؛ سبي عميق
المسافة / بولتون	حاجة 2 mm علويًا و3 mm سفليًا؛ بولتون متناسب
التحليل السيفالومتري	SNA 81°، SNB 75°، ANB 6°، FMA 24°، IMPA 97°
أخرى	البانورامية سلبية؛ نمط سميك؛ في ذروة النمو؛ لا انزلاق
التشخيص (الأداة 3)	صنف ثانٍ عظمي القسم 1، تراجع الفك السفلي؛ تتحسن الجانبية في العضة البنائية
قائمة المشكلات	1) سهمي (التراكب الأفقي) 2) عضة عميقة 3) ازدحام خفيف 4) عدم كفاية الإغلاق الشفوي

2 · الأهداف

الوجه / السهمي	تقديم الفك السفلي؛ أرحاء وأنياب صنف أول
التراكب الأفقي / العمودي	2–3 mm / 2–3 mm
الخلع / الإرساء	دون خلع (الأداة 2: القواطع السفلية مائلة أماميًا أصلًا، تُراقب)؛ إرساء متوسط
شُرح للمريض	ارتداء الجهاز الوظيفي، مرحلتان، مدة التثبيت

3 · تسلسل الميكانيكا

1. التقويم العظمي	Twin Block؛ مراقبة منتظمة للارتداء
2. التسوية	الانتقال إلى الجهاز الثابت: سلسلة NiTi ← فولاذ
3. العضة العميقة	تصحيح منحنى سبي، غرز أمامي
4. التنقيح	مطاط صنف ثانٍ خفيف عند الحاجة؛ torque ودوران

4 · المتابعة والإنهاء

المراجعات	على فترات منتظمة؛ توازي الجذور في بانورامية وسيطة
الإنهاء	التحقق من المفاتيح الستة؛ التراكب الأفقي والعمودي عند الهدف
التثبيت	Essix علويًا، لساني ثابت سفليًا؛ خطر الانتكاس: ميلان القواطع السفلية أماميًا

مادة تعليمية. لا تغني عن الفحص السريري وقرار الطبيب ورأي الاختصاصي.

الخطوة التالية

بعد تعبئة الورقة، وقبل لصق الحاصرات، راجع الخطة عبر **الأداة 5 · رادار أخطاء التخطيط**.
والمنطق الكامل للتخطيط في فصل **الوحدة 03 · التخطيط السريري: من قائمة المشكلات إلى الميكانيكا**.